护士开展失能老人家庭照护者照护指导工作体验的质性研究*

——王 璐 刘 菲 朱晓萍 黄渝婷 王子岳 王 莉

【摘 要】 目的 了解三级综合医院护士实施失能老人家庭照护者照护指导工作的体验,为促进优质护理资源下沉社区提供参考。方法 对20名上海市某三甲综合医院参与失能老人家庭照护者照护指导工作的护士进行半结构式访谈,运用Colaizzi现象学资料7步分析法进行内容分析。结果 共提炼出4个主题和8个类别:护理专业价值重构,涵盖家庭照护者照护能力提升带来成就感、职业价值和个人价值的体现和升华;角色拓展中的自我调适,涵盖护士角色延伸与专业胜任力挑战并存、非医院环境工作的顾虑与不适应;家庭情境下的沟通困境,涵盖护士与家庭照护者的健康信念冲突、家庭照护者情绪压力引发的沟通障碍;多重因素导致服务受限,涵盖时间不足与服务中断、缺乏多学科团队支持。结论 应完善一体化培训体系,促进护士居家照护能力与健康教育能力协同提升;提升失能老人家庭照护者健康素养,化解双方沟通障碍;重视角色适应与心理调适,调动护士积极性;构建以三级医院护士为主导的失能老人家庭照护者照护指导模式,从而有效提升失能老人照护质量。

【关键词】 护士;失能老人;家庭照护者;照护指导;照护工作体验

中图分类号:R47 文献标识码:A

A Qualitative Study on the Experiences of Nurses Providing Care Guidance to Family Caregivers of Disabled Elderly Individuals/WANG Lu, LIU Fei, ZHU Xiaoping, et al. //Chinese Health Quality Management, 2026, 33(1):43-48

Abstract Objective To understand the experiences of nurses in tertiary general hospitals in providing care guidance to family caregivers of disabled elderly individuals, providing references for promoting the sinking of high-quality nursing resources into communities. Methods Semi-structured interviews were conducted with 20 nurses from a tertiary grade-A general hospital in Shanghai who participated in care guidance for family caregivers of disabled elderly individuals. The content was analyzed using Colaizzi's seven-step phenomenological data analysis method. Results Four themes and eight categories were identified: reconstruction of nursing professional value, encompassing the sense of achievement derived from enhancing the caregiving capabilities of family caregivers, as well as the manifestation and elevation of occupational and personal values; self-adjustment in role expansion, covering the coexistence of nurse role extension and challenges to professional competence, along with concerns and maladjustment to working in non-hospital environments; communication dilemmas in family contexts, including conflicts in health beliefs between nurses and family caregivers, and communication barriers arising from the emotional stress of family caregivers; service limitations caused by multiple factors, involving insufficient time and service interruptions, as well as a lack of multidisciplinary team support. Conclusion It is essential to improve an integrated training system to facilitate the coordinated enhancement of nurses' home care capabilities and health education skills; elevate the health literacy of family caregivers of disabled elderly individuals to overcome communication barriers between both parties; emphasize role adaptation and psychological adjustment to mobilize nurses' enthusiasm; and establish a nurse-led care guidance model for family caregivers of disabled elderly individuals in tertiary hospitals, thereby effectively improving the quality of care for disabled elder-

DOI:10.13912/j.cnki.chqm.2026.33.1.10

*基金项目:国家自然科学基金资助项目"老年'慢性腰背痛—衰弱'共病综合管理模式构建与实证研究"(编号:72304210);上海市科学技术委员会计划项目"供需协同视域下失智失能老人家庭照顾者'喘息服务'共享模式构建及运作机制研究——基于社会嵌入理论"(编号:24692110500)

上海市第十人民医院护理部 上海 200072

中国知网 https://www.cnki.net

ly individuals.

Key words　Nurses; Disabled Elderly Individuals; Family Caregivers; Care Guidance; Care Experiences

First-author's address　Department of Nursing, Shanghai Tenth People's Hospital, Shanghai, 200072, China

失能老人指因生理机能退行性改变、病理性损伤或意外事件等因素导致基本生活自理能力显著降低或完全丧失的老年群体[1]。伴随人口老龄化进程加速及预期寿命延长，我国失能老人人口规模达5 271万人，预计到2050年将突破1亿人[1-2]。多项研究证实，失能不仅是加速老年人生理功能衰退与慢性病进程的重要因素，更是诱发抑郁和焦虑等负性心理情绪以及认知功能进行性衰退的关键风险因素[2,3-5]。

专业照护在延缓失能老人身体机能衰退，减少因照护不当而引发的紧急就医以及维持其生存质量方面发挥着至关重要的作用[6]。我国失能老人照护任务主要由家庭成员承担[7]，但因家庭成员专业知识和技能缺乏，导致失能老人出现营养不良、跌倒、压力性损伤等并发症，最终形成恶性健康循环[7]。此外，高强度照护负荷使照护者面临生理耗竭、社会角色受限以及心理健康受损等多重健康威胁[8]。针对上述问题，上海市第十人民医院与大宁路街道居家养老服务中心建立合作关系，依托医院丰富的护理资源，联合开展“失能老人家庭照护者照护能力提升服务”项目，旨在提升家庭照护者的专业照护技能，从而优化照护质量。本研究采用质性研究方法，深入访谈该院护士参与失能老人家庭照护者照护指导的体验，为促进三级综合医院优质护理资源有效下沉社区提供参考。

1　对象与方法

1.1　研究对象

采用目的抽样法，于2025年4—5月选取上海市某三甲综合医院参与失能老人家庭照护者照护指导工作的护士为研究对象。纳入标准：(1)在医院临床一线工作的护士；(2)年龄≥35岁；(3)工作年限≥10年；(4)本科及以上学历；(5)护师及以上职称；(6)参与失能老人家庭照护者照护指导次数≥5次；(7)知情同意，自愿参与本研究。排除标准：(1)因产假、外出学习等原因未从事临床护理工作时间≥3个月；(2)同时参加可能影响本项目护理实践的其他研究项目。样本量以资料饱和，即不再出现新的信息为准[9]，最终共纳入护士20名，研究对象基本情况见表1。本研究已通过医院伦理委员会审核(批件号：SHSY—IEC—5.0/24KY25/P01)。

1.2　研究方法

1.2.1 成立研究小组

研究小组共6名成员，包括护理部主任1名、片区科护士长1名、病区护士长1名、责任护士2名以及在读硕士1名。护理部主任提供咨询意见；片区科护士长负责质量控制；一名责任护士与在读硕士负责筛选受访对象、安排与协调访谈时间；病区护士长与另一名责任护士负责实施访谈、收集与分析访谈资料。

1.2.2 制订访谈提纲

访谈提纲围绕护士实施失能老

表1　护士开展失能老人家庭照护者照护指导工作体验研究受访对象一般资料(n=20)

编号	年龄/岁	性别	学历	职称	工作年限/年	工作科室	参与指导次数/次
N1	41	女	本科	主管护师	19	老年科	9
N2	43	女	本科	主管护师	24	神经外科	12
N3	36	女	本科	护师	14	老年科	10
N4	40	女	本科	护师	17	心血管内科	20
N5	35	女	本科	护师	12	神经内科	12
N6	38	女	本科	主管护师	14	骨科	7
N7	35	女	硕士	主管护师	14	内分泌代谢科	20
N8	38	女	本科	护师	16	内分泌代谢科	13
N9	41	女	本科	主管护师	18	骨科	15
N10	36	女	本科	护师	14	老年科	11
N11	39	女	本科	主管护师	16	心血管内科	10
N12	44	女	本科	主管护师	24	护理部慢病管理中心	20
N13	39	女	本科	主管护师	18	内分泌代谢科	10
N14	36	女	硕士	护师	10	骨科	10
N15	42	女	本科	主管护师	25	护理部慢病管理中心	7
N16	40	女	本科	主管护师	17	骨科	10
N17	36	女	本科	护师	13	骨科	8
N18	38	女	硕士	主管护师	15	神经内科	12
N19	38	女	本科	主管护师	18	老年科	11
N20	35	女	本科	护师	13	心血管内科	6

中国知网　https://www.cnki.net

人家庭照护者照护指导的体验进行设计，同时参考国内外相关文献，结合研究小组讨论结果，初步拟订访谈提纲。正式访谈前，选取符合纳入标准的3名护士进行预访谈，根据访谈过程中存在的问题进一步修订访谈提纲，最终形成访谈提纲如下：(1)您是如何看待护士提供上门照护指导服务这项工作的？(2)对于失能老人家庭照护者照护指导服务，您的总体感受如何？有没有让您印象特别深刻的事情？(3)您在提供服务的过程中遇到过哪些困难？您是如何克服的？您想得到什么帮助？(4)您觉得该项服务对于失能老人及其家庭照护者有哪些益处和不足之处？(5)作为护理专业人员，您认为如何通过医院—社区协作机制，更有效地发挥三级综合医院护理资源优势？

1.2.3 资料收集方法

采用半结构式访谈法收集资料，研究人员提前约定访谈时间，以不影响受访者工作为原则，访谈场所为病区会议室。访谈前，研究人员向受访者说明研究的目的、方法和内容，保护受访者隐私，承诺用编码代替姓名，明确访谈结果仅用于本研究，以消除其顾虑。取得受访者知情同意后进行访谈。访谈中，研究人员围绕访谈提纲，正确运用提问、倾听和回应技巧进行访谈，鼓励受访者充分表达感想，消除其紧张情绪；同时，仔细观察受访者的表情、语速和动作变化并及时记录。每次访谈时间30～40 min，且全程录音。整个访谈过程由两名研究人员共同完成，其中一名研究人员进行提问并灵活调整提问顺序和方式，另一名研究人员负责观察和记录。

1.2.4 资料分析方法

访谈结束后24 h内由两名研究人员独立将访谈录音逐字、逐句转录成文本资料，及时汇总并整理访谈笔记。采用Colaizzi现象学资料7步分析法[9]对文本资料进行分析，同一份资料由两名研究人员分别进行分析并提炼主题，经研究小组讨论后，确定主题并命名。在资料分析过程中，当两名研究人员提出不同意见时，运用合众法相互讨论后达成共识，并通过同行评审验证其合理性。此外，为保证资料的真实准确，研究人员将转录后的文本返回受访者进行求证，待确认无误后再进行分析与提炼。

2　结果

共完成访谈20次，无二次访谈，累计访谈时长772.6 min，转录文字206 283字。通过对转录文本的逐级编码、归纳、提取和总结，共提炼出4个主题及8个类别。

2.1　主题一：护理专业价值重构

2.1.1 家庭照护者照护能力提升带来的成就感

经过护士多次的示范、讲解与鼓励，大部分失能老人家庭照护者已逐渐掌握照护技能，给护士带来成就感。N13："我觉得很开心，因为在我的劝说和引导下，家属最终接受了我的建议，比如给老先生喂鳕鱼吃，白粥里放了虾仁和菠菜。"N16："当我教会了老太太如何正确进行翻身与体位摆放后，她和老先生之间多了体谅，少了相互抱怨，这种改变让我很欣慰。"N7："在我的指导下，陪护阿姨掌握了正确的胰岛素注射方法，老太太血糖逐渐趋于稳定，并且在我的多次沟通下，她儿女听取了我的意见，老太太由陪护阿姨陪同去看了心理医生，接受了正规治疗，后来她的身心状态得到了改善，真替她高兴。"

2.1.2 职业价值和个人价值得到体现和升华

护士积极参与家庭照护者照护指导工作，其职业价值和个人价值得到体现和升华。N20："我对护士这个职业的价值有了新的看法，具体来说就是在医院我们和医生一起守护生命，在失能老人家庭中我们负责'播种'健康，改善照护质量。"N3："我在日常工作中也常会接触到完全不能自理的老人，对于家庭照护者而言，要把老人照顾好确实不容易，我能有机会走进老人家里手把手进行指导，不仅给予了照护者实实在在的帮助，而且我的职业价值也得到了体现。"N13："时间久了，大家关系也拉近了很多，老太太有一次拉着我的手对我说如果有我这么一个女儿就好了，这种被尊重和需要的感觉让我觉得自己的付出非常值得。"

2.2　主题二：角色拓展中的自我调适

2.2.1 护士角色延伸与专业胜任力挑战并存

对于临床一线护士而言，为失能老人家庭照护者提供照护指导服务是其专业角色向社区健康促进延伸的体现。N1："原来我不仅能在医院开展急救工作，还能用自己的专业技能给家庭照顾者带来希望，感觉自己是问题解决者，这项工作让我有了全新的体验。"然而，多名护士反映该项工作对其专业胜任力构成挑战。N3："我很熟悉病房打针、发药、抢救配合等工作流程，但是到失能老人家里指导照顾者，我之前没有做过，担心自己做不好。"N9："我一直在外科工作，如果照护者提出来一些内科疾病的护理问题，我怕给予不了较为专业的指导。"N5："有一次在指导老人女儿协助老人进行床上被动运动时，老人很

中国知网　https://www.cnki.net

不配合，她女儿就抱怨说学了也没用，当时我也不知道该怎么去劝说了，这和我平时面对的住院患者完全不同。”

2.2.2 非医院环境工作的顾虑与不适应

护士在开展家庭照护者照护指导工作时，常存在因场景转换和资源差异而带来的多重顾虑与不适应。N8：“老先生的照护者是个男护工，每次去我都有点害怕，总觉得这样不太安全。”N1：“我觉得上门服务的时候如果配有一个便携式的报警装置就好了，万一有什么情况可以尽快得到救助。”N14：“老人家里空间很小，房间不但狭窄而且非常昏暗，造成我在向照护者做翻身示范时很难施展。”N17：“有一次，老人的儿子突然发脾气，把药瓶摔在地上，我当时装作很冷静的样子，但心里特别害怕。”

2.3　主题三：家庭情境下的沟通困境

2.3.1 护士与家庭照护者的健康信念冲突

在为失能老人照护者提供照护指导服务时，护士与家庭照护者可能会因健康理念不同而产生冲突。N2：“我看老人的骶尾部已经发红了，就和他女儿说需要每2 h翻身一次，他女儿却认为只要用艾草熏一下就可以了。”N13：“老先生是个脑肿瘤术后且合并糖尿病的患者，身体十分消瘦，我建议老伴做点鱼、虾、蟹等富含蛋白质的餐食给他吃，但老伴却觉得这些都是发物，不宜食用。”N14：“因为发现老太太的右手还有知觉，所以就指导她儿子帮助她每天进行10 min的抓握训练来防止肌肉萎缩，但他儿子态度上很抵触，认为老人瘫了就是瘫了，练也练不好，这样子反而让母亲遭罪。”N15：“老人儿子认为，我所说的压疮的处理方法和网上不一样，不接受我的建议。”

2.3.2 家庭照护者情绪压力引发的沟通障碍

家庭照护者情绪压力所引发的沟通障碍不仅影响失能老人的照护质量，还给护士上门照护指导工作带来负面影响。N12：“一位老太太向我倾诉说她整天围着老伴转悠，自己能保证每天三餐已经不错了，再要进行很多专业照护操作，她实在吃不消。”N16：“有一次，老太太和我边说边哭，我只能先停下来，安抚她的情绪，那次上门指导几乎都在听她哭诉这些年照顾老伴的不易。”N10：“在向家属提建议时，他很不耐烦，抱怨自己很忙很累，还说我就会讲理论。”

2.4　主题四：多重因素导致服务受限

2.4.1 时间不足与服务中断

部分受访护士提到了实施上门照护指导服务过程中的时间安排与服务中断问题。N18：“对于我来说，我觉得时间是个问题，因为小孩还小，休息日要在家带孩子，只有等下了白班才有时间去做上门指导，而下班这个点差不多也碰上老人家里的晚餐时间，所以总是非常匆忙地完成这个任务。”N6：“科室人员本来就紧张，不能保证准时下班，还需要经常加班，好不容易休息一天，我还要去做上门指导，自己时间就明显少了很多。”N9：“我完成了15次上门照护指导，由于老人意外住院、居住地变更等原因，期间更换了4个住址，我不断在建立新的服务关系，这种频繁的改变让我有点不知所措。”

2.4.2 缺乏多学科团队支持

护士在为家庭照护者提供健康指导时，经常会被问及超出其专业范围的问题，由于缺乏专科医生、心理医师、造口师等多学科团队的支持，使其难以给出具体意见。N2：“家属拿了一堆化验报告单让我看，然后问我需不需要调整药量或者更换其他药物，虽然我可以回答他，但觉得万一回答得不是很准确，可能会耽误老人病情，所以我在回答完后还是会建议家属陪老人去医院就诊。”N7：“老太太心理上出现了问题，如果有心理医生帮忙干预一下那就好了。”N4：“老先生造口周围的皮肤湿疹特别厉害，还有点破皮，尽管我及时进行了清理与更换，并教家属如何护理，但他这情况太严重了，得用防漏膏、皮肤保护膜这些敷料。但具体如何处理更到位，这超出了我的能力范围，只能推荐家属陪同老人去医院造口门诊。”

3　讨论

3.1　完善一体化培训体系，促进护士居家照护能力与健康教育能力协同提升

失能老人普遍合并多种慢性病，如痴呆、帕金森病、脑血管疾病等，且患慢性病种类和数量与失能状况存在互为因果的恶性循环关系[10]。这对失能老人照护者的居家照护能力提出了更高要求。在访谈过程中，多名受访护士表示，通过其专业指导，家庭照护者掌握了一定的居家照护知识与技能，提升了失能老人居家照护质量，体现了其专业价值和个人价值。然而，部分护士因居家照护相关知识与技能水平有限、健康教育方法欠妥等，影响了其照护指导的有效性，并使其产生无力感，这一专业认同分化现象与Derks CTAJ等[11]研究结果一致。本研究结果表明，护士在开展失能老人家庭照护者照护指导工作时所面临的挑战，不仅体现在居家照护专业知识的广度与深度方面，还在

中国知网　https://www.cnki.net

于如何将相关专业知识与技能有效转化并赋能给家庭照护者，可以认为，护士的居家照护能力与健康教育能力是相辅相成、不可分割的两个方面，两者直接影响其指导成效。相关研究指出，专业化培训体系是保障居家护理指导服务质量的关键因素[12]。此外，Rothausen CS等[13]认为，护士的权威性在避免与家庭照护者沟通障碍方面发挥着重要作用，有助于信息的顺畅传递和护理措施的及时执行。鉴于此，建议在专业理论知识与操作技能培训的基础上，建立集理论培训、临床实践技能培训与能力评估于一体的培训体系，重点聚焦老年慢性病综合管理、老年个案护理模式、老年综合征评估干预及安宁疗护等核心领域[14]，通过开发适用于居家照护场景的标准化课程模块、引入“Teach－Back”法(回授法)、开展情境模拟训练与角色扮演、创建并共享失能老人家庭照护者照护指导优秀案例库等策略，促进护士居家照护能力与健康教育能力协同提升。

3.2　提升失能老人家庭照护者健康素养，化解双方沟通障碍

健康素养是个体获取、理解并运用健康信息来做出适当健康决策的能力[15]。研究证实，失能老人家庭照护者的健康素养会在一定程度上影响失能老人的生活质量[16]。本研究发现，家庭照护者受认知偏差与情绪负荷(包括照护理念冲突、倦怠及焦虑等负性情绪积压)的双重影响，易出现健康信息接收阻抗现象，致使双方沟通效率降低，导致压力性损伤预防、营养支持、康复训练、心理调适等照护方案难以准确实施。这提示，护士需关注家庭照护者的健康素养提升，以化解双方沟通障碍。Jafari Y等[17]通过系统化授课方式对多发性硬化症患者家庭照护者实施疾病认知与护理技能指导，显著提升了其健康素养。Avci YD等[18]采用过渡护理模式为脑卒中患者家庭照护者提供为期13～20周的集综合指导、家庭访视、电话沟通以及线上培训于一体的指导，其健康素养持续提升。综上，在失能老人住院期间，建议护士通过科普图文资料、面对面健康宣教等方式，为家庭照护者提供疾病相关知识与居家护理操作规范等指导，使其逐渐接受专业化照护理念；在后续上门照护指导过程中，护士需进一步指导家庭照护者提升居家照护技能，同时运用正念减压等心理干预技术疏导其不良情绪，形成“院内学习－院外提升”的闭环式良性循环机制，既能提升家庭照护者健康素养，又可化解双方沟通障碍。

3.3　重视角色适应与心理调适，调动护士积极性

本研究结果显示，在非医院环境中为失能老人家庭照护者提供照护指导服务，易引发护士的适应障碍及焦虑情绪。对此，建议由医疗机构、街道居家养老服务中心等相关部门联合建立准入评估机制，筛查家庭照护者的暴力倾向史、精神疾病史、药物滥用史以及犯罪记录等风险因素，并采用结构化评估工具对服务环境的物理安全性(如照明条件、通讯设施、危险物品存放等)进行量化评估；同时，提前做好双向介绍工作，即向护士提供失能老人基本信息及照护指导服务接受者的详细评估报告，向家庭照护者公示上门服务护士的专业资质与服务范围。此外，建议医疗机构协同社区构建多维度支持网络，可通过定期组织沙龙活动，鼓励护士表达其心理体验及所需帮助，相关部门基于需求分析提供精准支持方案，如康复辅具供给、心理疏导及危机干预等。除上述举措外，主管部门还可对表现优秀的护士实施荣誉表彰与物质奖励相结合的双轨激励方案，从而调动护士参与失能老人家庭照护者照护指导工作的积极性。

3.4　构建以三级医院护士为主导的失能老人家庭照护者照护指导模式

失能老人家庭照护者的照护能力与照护质量呈显著正相关[19]。较高水平的照护能力不仅能够改善失能老人的生存质量，而且可以有效促进照护者主观幸福感提升[20]。为了有效提升失能老人家庭照护者的照护能力，该院护理部整合院内优质护理资源，协同街道居家养老服务中心，实施基于区域联动的失能老人家庭照护者照护指导服务。然而，访谈结果显示，现行实施方案在时间管理、工作延续以及多学科协作等方面亟待优化。针对运行过程中存在的问题，借鉴国内外相关经验[21－25]，建议构建以三级医院护士为主导的多学科失能老人家庭照护者照护指导模式。参与人员除三级医院护士外，还包括专科医师、营养师、康复治疗师、心理咨询师等，主要工作内容涵盖清洁护理、体位管理、营养支持、用药管理、康复训练、安全防护以及心理疏导等；服务方式则可采用线上(如微信视频指导、语音答疑等)与线下(上门指导)混合型指导模式，以增加护士与家庭照护者双方时间弹性，减少因各种因素所致的服务中断。同时，建立并推行“医院－社区－家庭”三方联动机制，三级医院负责提供专科理论指导和技术支持，社区整合辖区内失能老人家庭照护需求并协助护士开展上门指导工作，家庭照护者则需主动参与培训并及时反馈存在问题或困难，并且三方定期商讨照护指导上门服务优化方案，

中国知网　https://www.cnki.net

以确保照护指导的连续性和系统性。此外,建议三级医院与失能老人居住地所属社区卫生服务中心护理部协商建立转介机制,即根据失能老人的照护需求及难易程度对家庭照护者进行分层指导,基础照护指导(如环境评估、血压和血糖监测等)由社区护士完成,专科照护指导(如呼吸功能训练、康复训练、认知功能维护、生活方式管理、专科用药等)则由三级医院护士联合多学科团队完成。

作者贡献:王璐负责论文撰写,并且与黄渝婷共同负责实施访谈、收集与分析研究资料;刘菲负责研究选题、质量控制与论文修改;朱晓萍负责提供研究思路指导并提供咨询意见;王子岳与王莉负责筛选受访护士、安排与协调访谈时间。

利益冲突:所有作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

参考文献

[1] 乔梦婷,翁艳秋,陈文瑶,等.失能老人长期照护研究文献计量分析[J].军事护理,2022,39(11):29-32,37.

[2] ZHANG P,WANG L,ZHOU Q,et al. A network analysis of anxiety and depression symptoms in Chinese disabled elderly[J]. J Affect Disord,2023,333:535-542.

[3] LUO Y,SU B,ZHENG X. Trends and challenges for population and health during population aging—China,2015-2050[J]. CCDC Weekly,2021,3(28):593.

[4] CHEN L,WANG J,GENG L,et al. Development and validation of a risk prediction model for physical frailty in older adults who are disabled[J]. Geriatr Nurs,2024,58:26-38.

[5] AI F,LI E,DONG A,et al. Association between disability and cognitive function in older Chinese people:a moderated mediation of social relationships and depressive symptoms[J]. Front Public Health,2024,12:1354877.

[6] 杨　悦,郭全荣,田苗苗,等.失能老人照护者照护技术培训方案的设计与应用[J].护理学杂志,2025,40(8):105-108,119.

[7] 崔慧英,白　慧,邓欢欢,等.失能老人家庭照护者照护技能缺陷的影响因素及路径分析[J].军事护理,2024,41(3):5-9.

[8] HU H,HU X,XU Y. Caring load and family caregivers' burden in China:the mediating effects of social support and social exclusion[J]. Front Public Health,2023,11:1194774.

[9] 李　峥,刘　宇.护理学研究方法[M].北京:人民卫生出版社,2012:38-39.

[10] 王振杰,刘　蓓,郭占元,等.中国老年人失能情况Meta分析[J].中国老年学杂志,2020,40(8):1671-1674.

[11] DERKS CTAJ,HUTTEN-VAN DEN ELSEN MMGM,HAKVOORT LJ,et al. Hospital nurses' knowledge regarding older patients:a multicenter study[J]. BMC Nurs,2021,20:1-8.

[12] 刘薇群,张　娴,范恩芳,等.上海市慢性病社区护理模式的构建及应用[J].中国护理管理,2024,24(11):1617-1621.

[13] ROTHAUSEN CS,CLAUSEN AM,VOLTELEN B,et al. Protective buffering:nurses facilitating communication between adults with cancer and their adult family caregivers who overprotect one another—an integrative review[J]. J Fam Nurs,2023,29(4):417-436.

[14] 陈虹秀,杨　莘,胡秀英,等.我国30个省份老年专科护士队伍培养与工作现状调查研究[J].中华护理杂志,2021,56(9):1363-1368.

[15] SANDSTÖM N,JEKUNEN A,JOHANSSON M,et al. Association of health literacy with cancer survival:a single-centre prospective cohort study[J]. Acta Oncol,2025,64:42557.

[16] 张　咪,吴艳妮,黄秀娥,等.失能老人和配偶照顾者健康素养与自我效能对生活质量的交互作用[J].护理学报,2023,30(13):1-5.

[17] JAFARI Y,TEHRANI H,ESMAILY H,et al. Family-centred empowerment program for health literacy and self-efficacy in family caregivers of patients with multiple sclerosis[J]. Scand J Caring Sci,2020,34(4):956-963.

[18] AVCI YD,GÖZÜM S. Effects of transitional care model-based interventions for stroke patients and caregivers on caregivers' competence and patient outcomes:randomized controlled trial[J]. CIN,2023,41(10):805-814.

[19] 孙　敏,赵　琦,曹建琴.失能老人家庭照顾者居家照顾体验质性研究的Meta整合[J].解放军护理杂志,2022,39(6):22-25,43.

[20] NIU S,DING S,WU S,et al. Correlations between caregiver competence,burden and health-related quality of life among Chinese family caregivers of elderly adults with disabilities:a cross-sectional study using structural equations analysis[J]. BMJ Open,2023,13(2):e067296.

[21] TSENG MY,YANG CT,LIANG J,et al. A family care model for older persons with hip-fracture and cognitive impairment:a randomized controlled trial[J]. Int J Nurs Stud,2021,120:103995.

[22] TÖPFER NF,WREDE N,THEURER C,et al. Face-to-face versus telephone-based cognitive-behavioral therapy for family caregivers of people with dementia[J]. J Clin Psychol,2023,79(10):2270-2287.

[23] 白　慧,崔慧英,郝习君,等.基于Farran模型的失能老人照护者照护技能干预方案的构建与实施[J].护理学杂志,2023,38(15):87-91.

[24] MOU H,LAM S,CHIEN W. The effects of a family-focused dyadic psychoeducational intervention for stroke survivors and their family caregivers:a randomised controlled trial[J]. Int J Nurs Stud,2023,143:104504.

[25] 冯　梅,贺育华,蒋　艳,等.高质量发展背景下护理服务体系构建探索[J].中国卫生质量管理,2025,32(3):59-63.

通信作者:
刘　菲:上海市第十人民医院科护士长
E-mail:xianrenzh@126.com

收稿日期:2025-09-19
修回日期:2025-10-12
本文编辑:任红霞

中国知网　https://www.cnki.net